

Gynéco-Obstétrique — Sujet n°2 (SF L2)

EVALUATION DE GYNECO-OBSTETRIQUE LICENCE 2 SAGE FEMME

Répondre par vrai ou faux :

Réponse exacte : + 0,5 ; Réponse incorrecte : - 0,5

Lors de la TTC si le cordon se coupe, la révision utérine n'est pas indispensable F

La révision utérine se fait avec des gants propres F

Le cerclage se fait à partir de la 11e SA V

Le but de la GATPA est d'accélérer le décollement du placenta afin de réduire les pertes sanguines F

Dans la présentation de siège complet on perçoit les fesses et pieds du fœtus V

La procidence du cordon est la chute du cordon en avant de la présentation à membranes intactes F

Devant un HRP l'on doit prescrire un bilan sanguin avant toute action F

La CPN recentrée ne concerne que les grossesses à risque F

L'éclampsie se définit comme un syndrome convulsif survenant chez une femme enceinte en travail F

La CPN du 3e trimestre permet d'évaluer le pronostic d'accouchement par voie basse V

Le traitement prophylactique anti palustre débute uniquement lorsque la femme enceinte ressent les MAF F

Les facteurs de mortalité maternelle se traduisent par les 3 retards V

Dans la GEU les signes sympathiques de la grossesse sont moins marqués V

La procidence du cordon est une chute du cordon en arrière, de la présentation à membranes rompues F

Le traitement de la GEU consiste en une césarienne en urgence F

La MAP se définit par une modification du col associée à des contractions utérines, survenant entre 20 SA et 30 SA F

Le sulfate de magnésium permet la prévention de la crise d'éclampsie V

La rupture utérine fait partie des causes de métrorragies du 2e trimestre F

Dans l'HRP, l'étiologie la plus rencontrée est le traumatisme abdominal F

La SFA se traduit par une altération du rythme cardiaque fœtal et un RCIU F

Questions à choix multiple : Réponse exacte : + 0,5 ; Réponse incorrecte : - 0,5

Les différents placentas observés au cours du travail sont :

Le placenta praevia recouvrant

Le placenta praevia central

Le placenta non recouvrant

L'élément (ou les) suivant (s) fait (ou font) partie des facteurs de risque de l'hémorragie de la délivrance :

Antécédent d'hémorragie de la délivrance

Primiparité

Grossesse extra utérine

Dans quel pathologie l'hypertension artérielle est-elle un facteur favorisant :

Le placenta praevia

L'hématome retro placentaire

La rupture utérine

L'évaluation du bien-être fœtal est appréciée par :

Le rythme cardiaque fœtal

Degré de modelage de la tête

Le niveau de la présentation fœtale

La grossesse extra-utérine est :

Une grossesse qui peut évoluer à terme

Une prolifération anormale du trophoblaste

De localisation abdominale dans la majorité des cas

L'implantation de l'œuf en dehors de la cavité utérine

Quels sont les signes cliniques en faveur d'une GEU ?

L'utérus est augmenté de volume

Des métrorragies minimales sépia

L'œuf est perçu sous la peau

Masse latéro-utérine

Les métrorragies du premier trimestre doivent évoquer en premier lieu :

Une grossesse arrêtée

Une GEU

Une grossesse molaire

Une rupture utérine

Les objectifs de la 1ère CPN sont :

Réévaluer les facteurs de risque

Vérifier la bonne évolutivité de la grossesse

Faire les prescriptions V

Confirmer la grossesse V

Les examens sanguins faisant partie du bilan biologique de la CPN sont :

Groupe sanguin et Rhésus V

ECBU

Électrophorèse des protéides sanguines

Uricémie

Ag HBe

Citez deux causes fœtales de prématurité

Hydramnios V

Grossesse multiple V

Anémie

HTA

Quels sont les gestes à faire en cas de procidence du cordon battant :

Recouvrir le cordon avec des compresses humides V

Installer la patiente en décubitus latéral gauche pour accélérer le travail

Faire des TV réguliers pour surveiller la descente du fœtus

Hospitaliser la patiente

Donner les signes de l'éclampsie :

Barre épigastrique V

Convulsions généralisées

Nausées V

Troubles sensitifs

Macrosomie

En cas de placenta prævia on peut retrouver les signes suivants :

HU excessive

Signes de choc non en rapport avec les saignements

Col cerclé

Perception d'un matelas placentaire V

Les signes suivants sont retrouvés le plus souvent dans la rupture utérine :

BDCF présents

Col cerclé

Présentation fœtale fixée au TV

Fœtus perçu sous la peau V

Quels sont les complications liées à l'HRP :

Choc hypovolémique V

Rupture utérine

Fièvre

Endométrite